Guía de estudio — Examen de octubre

Oct 14, 2026 · @Irving Guerra

Cómo usar esta guía

El PDF son 14 temas (239 páginas) de la asignatura Gestión en Salud, de la Maestría en Dirección y Administración en Salud (UNIR). Esta guía lo reduce a lo que más se pregunta: definiciones, listas, siglas y cifras.

1. Mira el diagrama: casi todos los temas son una pieza del mismo ciclo (planificar, organizar, pactar, evaluar y mejorar).
2. Estudia el resumen de cada tema. Lo que está en **negritas** es lo más preguntable.
3. Repasa el glosario tratando de definir cada término antes de leerlo.
4. Resuelve las 43 preguntas sin ver las respuestas y regresa a los temas donde falles.
5. La víspera, lee solo el repaso de último minuto.

Mapa del temario (entre paréntesis, las páginas del PDF)

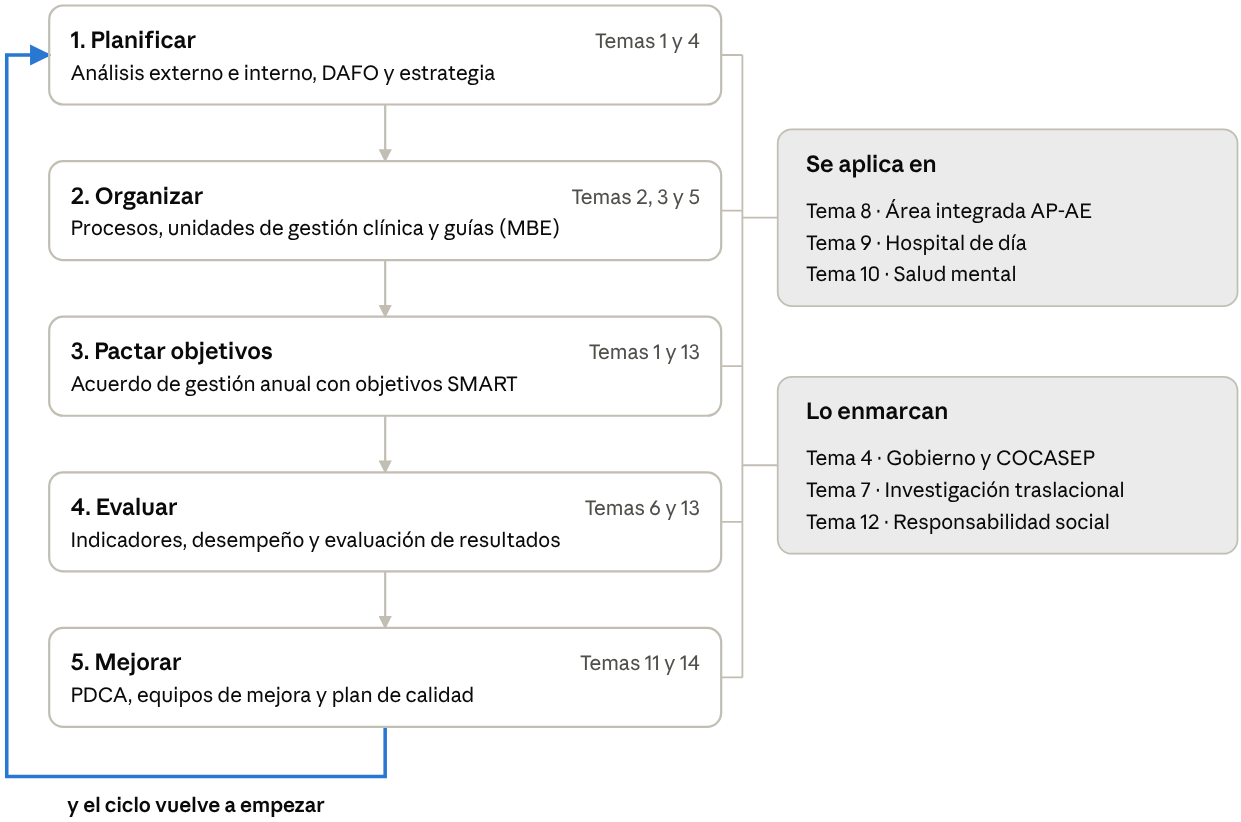
- **Tema 1 · Gestión clínica** (págs. 1–20): fases, DAFO, acuerdos de gestión, área integrada.
- **Tema 2 · Gestión por procesos** (21–34): proceso, mapa de procesos, indicadores.
- **Tema 3 · UGC e integración de profesionales** (35–47): 7 principios y 8 barreras.
- **Tema 4 · Gobierno, transparencia y rendición de cuentas** (48–69): contexto, COCASEP, órgano de gestión.
- **Tema 5 · Variabilidad de la práctica clínica** (70–87): MBE, GPC, CENETEC, MECIC.
- **Tema 6 · Evaluación del desempeño** (88–109): indicadores de México y modelos internacionales.
- **Tema 7 · Investigación traslacional** (110–117): fases T0–T4.
- **Tema 8 · GC en un área integrada** (118–124): atención primaria + especializada.
- **Tema 9 · Hospitales de día** (125–143): definiciones legales, tipos, organización.
- **Tema 10 · Unidades de salud mental** (144–176): unidades, estancias, indicadores, estigma.
- **Tema 11 · Plan de calidad** (177–199): 15 recomendaciones, cuadro de mando.
- **Tema 12 · RSC** (200–210): triple cuenta, qué no es RSC, 11 áreas.
- **Tema 13 · Evaluación de resultados de una UGC** (211–225): SMART, indicadores, evaluación en fases.

- **Tema 14 · Ciclo de mejora** (226–239): equipos de mejora, PDCA, kaizen.

Si tienes poco tiempo, prioriza los temas 1, 2, 6, 10, 13 y 14: son los que concentran más listas y cifras (es mi estimación, no algo que diga el temario).

Los 14 temas forman un solo ciclo de gestión

Cada paso indica en qué temas se estudia; a la derecha, dónde se aplica y qué lo enmarca



El ciclo de gestión · 5 pasos y dónde va cada tema

Planificar, organizar, pactar, evaluar y mejorar es el esqueleto del curso; ubicar cada tema en su paso hace más fácil recordar sus listas.

Resumen por tema

Cada tema abre con su idea central en una línea y sigue con las listas, definiciones y cifras que el PDF repite o destaca.

Tema 1. Gestión clínica

Idea central: la gestión clínica (GC) es la **suma de la práctica clínica y la gestión de recursos**, con sentido común. La práctica va con evidencia y la gestión valora la efectividad frente a los costes.

Definición formal: organización estructural y funcional de un servicio, con despliegue estratégico vinculado a la organización, que acuerda y evalúa su gestión mediante el liderazgo clínico y de gestión, y que se plasma en los **acuerdos de gestión**. Debe ser participativa, **orientada a procesos** y basada en la **continuidad asistencial**.

Por qué cambiar: envejecimiento y cronicidad, nuevas tecnologías de información, innovación permanente, pacientes más activos y aumento del gasto sanitario.

Las 4 fases del proceso de GC

- **Planificar:** saber **qué** hacer (situación, objetivos, estrategias) con el análisis externo e interno y el **DAFO**.
- **Organizar:** definir **cómo**: organigrama, cartera de servicios, estructura, procesos operativos, métodos, procedimientos y normas.
- **Dirigir o coordinar:** liderar, comunicar y motivar; le toca al responsable del servicio.
- **Evaluar:** medir con indicadores, retroalimentar a los profesionales y corregir.
- **DAFO:** análisis externo = **oportunidades** (nos favorecen) y **amenazas** (nos perjudican); análisis interno = **fortalezas** y **debilidades**. Ojo: el PDF dice por error «fortalezas y amenazas» en el análisis interno.
- **Qué hacer con el DAFO:** corregir debilidades, afrontar amenazas (innovar), mantener fortalezas y explorar oportunidades.
- **Gestionar = coordinar y motivar.** Coordinar es planificar, organizar, distribuir trabajo y personas y aportar medios. Motivar es liderar, incentivar y crear cultura y clima.
- **Especialidades:** salud mental (asistencia, promoción, prevención, rehabilitación e integración social); geriatría (paciente **pluripatológico y frágil**); pediatría (los **padres** forman parte de todo el proceso).

Acuerdos o contratos de gestión: instrumentos que garantizan los compromisos firmados entre un área de gestión y su gerencia. Son **anuales** y deben desplegarse a todos los profesionales.

- **5 elementos para prepararlo:** plan anual de gestión del servicio de salud, planes de la especialidad (p. ej., cronicidad), plan estratégico del centro o área, plan estratégico del servicio y resultados anteriores.

- **11 tipos de objetivos:** accesibilidad, actividad asistencial, resultado clínico, orientación al paciente, investigación e innovación, formación continuada, docencia, objetivos compartidos con otras unidades, cronicidad, educación sanitaria y continuidad asistencial.
- **Ficha de un indicador:** objetivo, nombre, fórmula, población, fuente de datos, responsable, periodicidad y estándar. Ejemplo: satisfacción global en consulta externa, medida trimestral, estándar **> 95 %**.

GC en un área integrada: modelo **centrado en el ciudadano** que da a los profesionales más autonomía y responsabilidad, y busca continuidad entre atención primaria (AP) y especializada (AE). La solución típica es la **gerencia única de área**.

- **Soria** (Castilla y León): Área de Gestión Integrada creada en **noviembre de 2011**, ~1600 trabajadores, más de 120 M€; en 2015 fue la primera de España con el **Sello de Excelencia Europea 500+**.
- **Comunidad Valenciana: 24 departamentos** con 4 pilares: financiación capitativa, gestión integral, facturación entre departamentos y dirección por objetivos.
- **Madrid (2015):** crea la **Dirección de Continuidad Asistencial (DCA)**, ubicada en el hospital y dependiente del gerente.
- **Críticas:** hospitales hipertrofiados y AP burocratizada que atiende casos banales; se mantiene la doble estructura AP-AE, sin presupuesto único ni gestión por procesos.

Tema 2. Gestión por procesos

Idea central: las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos. Para implantar la gestión por procesos primero hay que **identificar la estrategia**, y el despliegue es **paulatino y en cascada**.

- **Proceso:** conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma **secuencial y ordenada** para conseguir un resultado que satisfaga plenamente al paciente o población.
- **Según ISO 9000:2005:** actividades relacionadas que **transforman entradas en resultados**. El enfoque aparece en la familia ISO 9000 y en el modelo EFQM.
- **Características: variabilidad** (cada repetición varía un poco) y **repetitividad** (permite mejorarlo).
- **Principios:** interacciones entre procesos, requisitos de clientes internos y externos, mejora continua (eficacia y eficiencia) y ciclo PDCA.
- **Propietario del proceso:** quien lo conoce, decide sobre él, lo supervisa y evalúa sus resultados.

- **Tipos de proceso: estratégicos** (desarrollan la estrategia y fijan objetivos), **operativos o clave** (la actividad propia, en contacto con el cliente) y **de soporte o apoyo** (dan los recursos a los clave).

Los tres juntos forman el **mapa de procesos**, que debe incluir las relaciones entre ellos.

- **Ficha de un proceso:** entradas, salidas, procesos, secuencia de actividades, diagrama de flujo, recursos e indicadores.
- **Qué se mide:** cantidad, calidad técnica (incluye indicadores centinela), calidad percibida (encuestas) y coste.
- **Criterio:** lo que se desea obtener; para la Joint Commission, la condición que debe cumplir la práctica para ser de calidad. **Indicador:** medida cuantitativa de un criterio; puede haber varios por criterio. **Estándar:** el nivel aceptable.
- **Monitorización** = seguimiento de indicadores. **Solo monitorizar no mejora el proceso.**
- **6 características de un indicador:** concreto, objetivo, específico, clínicamente válido, relevante y eficiente.
- **Cómo se mejora:** primero hacer que ocurra como queremos (definir, realizar, comprobar); después aplicar acciones de mejora con PDCA. Toda mejora debe verse en los indicadores.
- **4 barreras:** organizacionales («siempre hemos trabajado así»), actitudinales (cambio impuesto, lenguaje lejano a la clínica), carencias estructurales y de cualificación, y expectativas irreales.
- **5 ventajas:** orientación al cliente, más eficacia y eficiencia, estructura las actividades, mejor seguimiento de resultados y facilita planificar objetivos.

Tema 3. Unidades de gestión clínica e integración de profesionales

Idea central: la GC integra a los profesionales, pero choca con 8 barreras. Se superan con **liderazgo, apoyo institucional, formación y buenos sistemas de información**.

- **UGC e institutos:** instrumentos de integración. Las UGC integran dentro de un mismo servicio; los institutos incorporan varios servicios.
- **Según Ortún:** «gestión» es coordinar y motivar personas; «clínica» son las decisiones diagnósticas y terapéuticas.
- **7 principios de la GC:** integración de los profesionales, participación activa en los objetivos, autonomía, gestión por procesos, organización centrada en el paciente, medicina basada en la evidencia (MBE) y sistemas de información adecuados.

Las 8 barreras (problema → salida)

- **Cultura:** clínicos centrados en el diagnóstico y gestores en la actividad; variabilidad vista como derecho; se culpa a la persona y no al sistema; paternalismo → comunicación, misión y valores, incentivar.
- **Liderazgo:** jefe orientado al control → **jefe facilitador** y trabajo horizontal.
- **Organización:** organigramas verticales, metas no compartidas, poca autonomía económica → unidades interdisciplinares; **autonomía unida a responsabilidad** (Cabo, 2014).
- **Estrategia:** no se apuesta por la GC o hay vaivenes → integrarla en los planes estratégicos.
- **Formación en gestión:** pregrado y posgrado sin gestión, calidad ni bioética → exigirla a mandos y directivos.
- **Estilos de práctica:** rutinas sin evidencia, desconexión médico-enfermería, líder autoritario → paciente en el centro y MBE.
- **Sistemas de información:** pensados para directivos, no llegan al equipo → diálogo, datos depurados, cuadro de indicadores.
- **Transparencia:** centros opacos → cartas de servicios, RSC, benchmarking.
- **Niveles de gestión (Del Llano, 2014): macrogestión** = el Estado (equidad y fallos del mercado); **mesogestión** = gestión de centros; **microgestión** = gestión de la práctica clínica.
- **Frase de Minúé:** «que la gestión sea más clínica y la clínica más gestora».
- **Conclusión:** los obstáculos están identificados y son superables con metodología e integrando voluntades.

Tema 4. Modelos de gobierno, transparencia y rendición de cuentas

Idea central: el buen gobierno exige analizar el contexto externo e interno y profesionalizar la gestión con órganos transparentes. En México ese órgano de calidad es el **COCASEP**.

- **Contexto:** el sistema público español vive una **crisis sistémica de sostenibilidad**. En **2001** la Comisión de las Comunidades Europeas asumió el informe de buen gobierno del Consejo de Europa. Ejemplo de norma: **Ley 11/2017** de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión (Madrid). El autor sigue la postura de **SEDISA**.
- **Contexto externo:** factores que la organización **no controla** (económicos, políticos, legales, tecnológicos, culturales); pueden ser amenazas u oportunidades.
- **Contexto interno:** uso efectivo de los recursos, fortalezas, debilidades y **capacidades dinámicas** de adaptación.

- **3 esferas de toda organización** (Chiavenato y Sapiro, 2017): sistema **gerencial** (administración y objetivos), **técnico** (flujo de procesos y estándares) y **social** (talento humano y cultura).
- **5 competencias del tomador de decisiones asertivo:** dominio de sí mismo, comprender las percepciones de los clientes, visión amplia del futuro, generar un entorno colaborativo y **razonamiento sistémico**.
- **Nuevas circunstancias del entorno:** densidad urbana, dinámicas sociales, recursos naturales limitados, cambio climático, innovación tecnológica, nivel educativo, migración y asentamientos en zonas de riesgo.
- **6 áreas funcionales:** operaciones, marketing, investigación y desarrollo, finanzas, recursos humanos y la cadena de procesos de servicios de salud (la **parte medular**).
- **Modelo de Gestión de Calidad (México), 5 resultados de valor:** salud de la población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, experiencia satisfactoria y costos razonables. La comunidad participa con el **aval ciudadano**.

COCASEP (Comité de Calidad y Seguridad del Paciente): órgano colegiado de carácter **técnico consultivo** que analiza los problemas de calidad y define acciones de mejora continua y seguridad del paciente. Su composición viene del DOF del 27/12/2012.

- **Presidente = director** del establecimiento: preside, aprueba el orden del día, tiene **voto de calidad** en empate, autoriza subcomités, firma minutas y fija criterios de la Memoria Anual.
- **Secretario técnico = gestor de calidad:** coordina el **Plan de Mejora Continua (PMC)**, convoca, hace minutas, da seguimiento, coordina la Memoria Anual y convoca a los avales ciudadanos.
- **Vocales:** subdirector médico, subdirector administrativo, enseñanza o investigación, jefatura de enfermería y de trabajo social. Eligen casos, aplican la metodología, opinan sobre factibilidad y elaboran informes.

Órgano de gestión (propuesta para España): miembros natos de la Consejería de Sanidad y el resto nombrados por el órgano de gobierno. Lo preside la Consejería o Viceconsejería de Sanidad, y la Secretaría es del Servicio Autonómico de Salud.

- **Sus funciones clave:** seleccionar y cesar a la **dirección gerencia** en un proceso público y transparente; la gerencia tiene **voz y voto** para elegir al resto de direcciones; participar en el contrato de gestión; aprobar y supervisar el plan estratégico; hacer visible a los ciudadanos la actividad, la calidad y el presupuesto.

- **También debe:** reducir la variabilidad, humanizar la asistencia, integrar AP, urgencias y hospital, impulsar la telemedicina e incentivar según la ***lex artis*** (evidencia científica + centrada en el paciente).
- **Idea clave del tema:** no hay una fórmula única de calidad; cada establecimiento diseña la suya según su realidad.

Tema 5. Variabilidad de la práctica clínica

Idea central: hay variabilidad porque las poblaciones son distintas, la oferta es diversa y los profesionales actúan distinto ante casos parecidos. La **MBE** es la mejor herramienta para reducirla.

- **Dos causas en los profesionales: incertidumbre** (no existe evidencia sobre las alternativas) e **ignorancia** (la evidencia existe, pero no se conoce o no se aplica).
- **MBE:** uso **consciente, explícito y juicioso** de la mejor evidencia disponible para decidir sobre el cuidado de los pacientes. Integra la experiencia clínica y las preferencias del paciente.
- **Guías de práctica clínica (GPC):** recomendaciones basadas en MBE, experiencia de expertos y valores del paciente, para intervenciones efectivas, seguras y al mejor costo.
- **México:** en **2007** nace el **Programa Nacional de GPC**, coordinado por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud a través del **CENETEC**, que integra el **Catálogo Maestro de GPC**.
- **Fuente 1, la propia población:** estructura demográfica, nivel socioeconómico y escolar, prevalencia, factores de riesgo y gravedad. El sistema **difícilmente** puede influir.
- **Fuente 2, el sistema sanitario:** recursos humanos, técnicos y financieros, cobertura, accesibilidad, **incentivos económicos**, capacitación, nuevas tecnologías y falta de equipo o especialistas. Aquí **sí** puede influir.
- **Caso histórico:** la **amigdalectomía en niños** variaba entre hospitales y dentro del mismo hospital por falta de criterios unificados. A la variabilidad propia del médico se le llamó **«estilo de práctica profesional»**.
- **Epidemiología clínica:** análisis epidemiológico aplicado a decisiones sobre pacientes individuales.
- **Consecuencias:** riesgo de **iatrogenia**, falta de efectividad y gasto inadecuado. Aplicar mal la evidencia es variabilidad **injustificada**.

- **Retos para la dirección:** personal que no conoce la MBE, resistencia al cambio y falta de motivación. Ayudan los **facilitadores**, las áreas de difusión y capacitación, y los instrumentos que miden el apego a las GPC.
- **Medicina de las 4P:** preventiva, predictiva, personalizada y participativa; atiende **enfermos, no enfermedades**. Busca prevenir complicaciones, aumentar la capacidad intrínseca y controlar el dolor.
- **Dónde buscar evidencia: Cochrane** (revisiones sistemáticas), NHS Centre for Research & Development (revisiones y costo-efectividad), **MEDLINE/PubMed**, National Clearinghouse y New Zealand Guidelines (fuentes secundarias para GPC). Después viene la lectura crítica.
- **MECIC** (Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad): mide el apego a las GPC con **11 algoritmos**. Tiene 3 apartados (archivo clínico, expediente estomatológico y expediente integrado y de calidad), se captura **cada cuatrimestre** y depende del Subcomité de Calidad del Expediente Clínico del COCASEP.
- **Retos futuros:** estudiar la variabilidad que afecta a la seguridad, reforzar las agencias de evaluación de tecnologías (y la **desinversión** en lo inefectivo) e incorporar la experiencia del paciente a las GPC.

Tema 6. Evaluación del desempeño de centros, unidades y servicios

Idea central: «**no se puede gestionar lo que no se puede medir**». Evaluar el desempeño exige indicadores definidos, métodos para medirlos, estrategias de recogida de datos y procedimientos para sintetizar y notificar resultados.

- **Recomendación del tema:** mejor un conjunto **pequeño de indicadores centinela** que medirlo todo, combinando indicadores de resultado, de producción y de proceso.
- **México:** la evalúa la **Dirección General de Evaluación del Desempeño** de la Secretaría de Salud.

Los 8 proyectos de indicadores de México

- **INDICAS:** calidad de gestión, técnica e interpersonal; **111 variables → 28 indicadores → 8 índices → 3 rubros** (trato digno, organización de los servicios y atención médica efectiva).
- **PROSESA:** rendición de cuentas y acceso a la información pública; **274 líneas de acción, 39 estrategias, 6 objetivos**.
- **Indicadores de resultados:** esperanza de vida, nacimientos, defunciones y atención a menores de 5 años.

- **Caminando a la Excelencia:** vigilancia epidemiológica; **7 indicadores, 23 programas de acción**.
- **Objetivos del Milenio:** metas internacionales.
- **PREVENIMSS:** prevención en el IMSS, con el **SAIS** (registro nominal en primer nivel).
- **OCDE:** estado de salud, acceso, factores de riesgo, recursos y calidad; 4–7 indicadores por dimensión.
- **Observatorio del Desempeño Hospitalario:** el sistema hospitalario.

Los 6 objetivos del PROSESA: protección, promoción y prevención; riesgos a la salud; Sistema Nacional de Salud Universal; uso efectivo de recursos; reducir brechas entre grupos y regiones; y acceso efectivo con calidad.

Modelos internacionales

- **OMS / OPS:** 5 ejes: acceso, calidad, equidad, eficiencia y sustentabilidad. Acceso = barreras **físicas** y **económicas**. Equidad = subsidios y **coeficiente de Gini**. Calidad = indicadores de estructura, proceso y resultado (mortalidad infantil y materna, fecundidad, VIH/SIDA).
- **OCDE:** adopta el de la OMS con cambios: añade resultados (eficiencia **micro**económica), acceso como «capacidad de respuesta» y gasto como meta (eficiencia **macro**económica); **sin ponderaciones**; solo asistencia médica.
- **NHS (Reino Unido): PAF**, basado en el cuadro de mando integral, con **51 indicadores y 6 dimensiones**: mejora de la salud y menos desigualdad, acceso justo, cuidado apropiado y efectivo, eficiencia, experiencia del paciente y cuidador, y resultados de salud.
- **Australia (NHPC):** creado a finales de los 90; mide, promueve el **benchmarking** e informa. **3 metas**: llevar la evaluación a medicina general y salud pública, conectar con otros profesionales y mejorar la información. Acredita hospitales con **18 indicadores**.
- **Canadá (CIHI):** se basa en el informe **Lalonde (1974)**, en **Evans y Stoddart (1994)** y en la salud poblacional. **4 dimensiones y 16 categorías**: estado de salud, determinantes no médicos, funcionamiento del sistema, y comunidad y sistema. La **equidad** es transversal.

España

- **Problema:** no hay un marco común; sobran datos de recursos y actividad y faltan datos de resultados.
- **Ministerio de Hacienda (2015):** modelo de evaluación del desempeño de empleados para mejorar el rendimiento, recompensar y liderar el cambio.

- **Plan de Calidad del SNS (2006), estrategia 12:** un sistema de información fiable, oportuno y accesible. De ahí salen los **Indicadores clave del SNS (INCLASNS)**, con **16 dimensiones**, y un informe anual al Consejo Interterritorial.
- **REBECA:** repertorio básico de estadísticas de las comunidades autónomas, en **8 grupos** (población, estado de salud, determinantes, sistema sanitario, gasto, medicamentos, derechos de los consumidores y síntesis).
- **Cataluña, Central de Resultados:** mide, evalúa y difunde. Su **indicador sintético de adecuación** junta **10 indicadores en 4 áreas**: estancias de más de 20 días, cesáreas, hospitalizaciones evitables y urgencias.
- **Madrid, Observatorio de Resultados:** 3 áreas: estado de salud, atención primaria y hospitales.

Tema 7. Investigación traslacional

Idea central: «la investigación básica tiene respuestas pero no conoce las preguntas; la clínica tiene preguntas pero no las respuestas». La traslacional une ambos mundos.

- **Definición:** aplica el conocimiento científico que ya demostró ser eficiente en intervenciones de salud, lo hace útil a la población y maximiza el retorno de lo invertido (Máñez Ortiz, 2013). Combina un enfoque **clínico y epidemiológico**.
- **Instituciones:** los **Institutos de Investigación Sanitaria (IIS)** la fomentan; su acreditación se regula en el **RD 339/2004**.
- **Las 5 fases: T0** investigación básica → **T1** posibles aplicaciones → **T2** aplicación en la comunidad, en contextos reales → **T3** identificar el máximo beneficio → **T4** mantener el beneficio de forma sostenida.
- **Metodología en 4 pasos:** identificar a los profesionales que usarán el conocimiento (uno con experiencia y autoridad); sumar a profesionales del mismo nivel; explorar la factibilidad con pilotos; buscar cambios de conducta, sostenibilidad y transferencia a la atención.
- **3 objetivos:** responder a los problemas que plantea la clínica, **acortar los tiempos** de aplicación y **centrar la investigación en los pacientes**.
- **Integración:** la I+D orientada al paciente y la orientada a la enfermedad convergen en la I+D centrada en la práctica clínica, que se incorpora al sistema sanitario. Se busca el **retorno de la inversión de los fondos públicos** de I+D.
- **3 cambios necesarios:** de actitud y procedimiento (administraciones, directivos y clínicos); reorientar las prioridades y los fondos; y revisar cómo se evalúa la calidad de la investigación (no solo con el factor de impacto) y de las tecnologías.

Tema 8. Gestión clínica en un área integrada

Idea central: el sistema se organiza en **áreas sanitarias**; integrar atención primaria y especializada da cuidados **menos fragmentados, más coordinados y de mayor calidad**. Complementa el apartado 1.6 del tema 1.

- **Barreras al cambio** (Gatica y Rosales, 2012): falta de coordinación administrativa entre niveles, pobres incentivos al personal y estructuras burocráticas rígidas.
- **GC en este tema:** más que administrar, es una **reingeniería**. Mejora los procesos administrativos y asistenciales para usar con eficiencia los recursos tecnológicos, humanos, organizacionales e intelectuales.
- **Proceso** (Tovar, 2014): actividades relacionadas, con entradas y salidas, que generan **valor agregado**.
- **3 medios:** gestión adecuada de procesos, decisiones basadas en la evidencia y trabajo en equipo. El choque entre clínicos y gestores se maneja con comunicación.
- **Situación actual:** usuarios más informados y exigentes; las TIC permiten diagnóstico a distancia, monitoreo de pacientes críticos y cuidados domiciliarios.
- **La GC es el enlace** entre clínicos, pacientes y directivos.

Tema 9. Gestión de hospitales de día

Idea central: el hospital de día (HD) atiende durante **unas horas**, sin ingreso. Su **cartera de servicios** lo define y condiciona su gestión, instalaciones, personal y ubicación.

- **Definición (RD 1277/2003):** unidad donde, bajo supervisión o indicación de un **médico especialista**, se trata a enfermos que requieren durante unas horas atención continuada médica o de enfermería, pero **no el internamiento**.
- **Historia:** hasta los años 70 solo había régimen ambulatorio o internado (instituciones «abiertas» o «cerradas»). Entre 2000 y 2007 en España bajaron las camas y las plazas de HD **se duplicaron hasta 23,3 por 100 000 habitantes**.
- **Marco legal:** la **Ley 14/1986, General de Sanidad**, crea el SNS. La **Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad**, lo vertebra; su **art. 13** incluye el HD médico y quirúrgico en la atención especializada y pide atender en consultas externas y HD siempre que se pueda. Es decir, se **prima la no hospitalización**.
- **Otras unidades del RD 1277/2003: cirugía mayor ambulatoria** (especialista; anestesia general o locorregional; cuidados postoperatorios cortos; sin ingreso), **cirugía menor ambulatoria** (anestesia **local**; baja complejidad; sin cuidados postoperatorios) y **diálisis** (responsable: especialista en **Nefrología**).

Tipos de hospital de día

- **Médico-quirúrgico:** polivalente, propio de **hospitales pequeños**; transfusiones, paracentesis, tratamientos parenterales; turno de mañana; parte de su actividad no es programada.
- **Quirúrgico:** CMA y procedimientos cruentos; conectado al bloque quirúrgico; mañana y tarde; **abre antes que el resto del hospital**; el **anestesista** da el alta.
- **Médico:** infecciosos, reumatología, neurología, dermatología; coordinación con Farmacia por los **biológicos**.
- **Oncológico u onco-hematológico:** quimioterapia y **citostáticos**; más intimidad y espacio para acompañantes; sin rotación de pacientes en la jornada.
- **Integrados en un servicio:** psiquiátrico, infecciosos-VIH, digestivo, diálisis, pediátrico (el **más polivalente**) y geriátrico; mismo jefe y supervisora.
- **Unidades de día: no** son HD por su tamaño; son el germen de los HD médicos.
- **Organización:** el Plan de Calidad del SNS rediseña procesos con **2 pilares**: seguridad del paciente y **estándares y recomendaciones** (no son normativos).
- **5 requisitos de una Unidad de Hospitalización de Día:** estructura física diferenciada, cartera de servicios, protocolos y normas, personal dedicado y una persona al frente.
- **Estructura física:** recepción y admisión, zona de espera (no imprescindible), área de tratamiento (sala diáfana o, lo ideal, cubículos), control de enfermería, consulta (no imprescindible si hay cubículos), despacho, aseos, vestuarios y oficios de apoyo.
- **Cartera típica:** cuidados tras procedimientos, técnicas cruentas (biopsias, punciones) y administración de tratamientos (quimioterapia, biológicos).
- **6 tipos de protocolos:** clínicos, de gestión de pacientes, de infección nosocomial (programa **Bacteriemia Zero**), de seguridad clínica, de servicios generales y de mantenimiento. Cada protocolo indica quién lo elaboró, revisó y aprobó.
- **Personal:** especialistas, enfermería, auxiliar y celador, con una **supervisora de enfermería** al frente.

Tema 10. Gestión de unidades de salud mental

Idea central: la UGC de salud mental da **atención integral** con un **modelo comunitario**, busca la máxima autonomía del paciente y gira alrededor del **plan individualizado de rehabilitación (PIR)**.

- **Salud mental (OMS):** estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades, afronta el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y contribuye a su comunidad.
- **GC aquí:** uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor cuidado. Implica descentralizar y **transferir riesgos** a las unidades (pueden ganar o perder según sus resultados).
- **Planificación estratégica:** misión (razón de ser, no la cartera de servicios), visión (ser unidades **excelentes e innovadoras**), valores, código ético y factores críticos de éxito.
- **5 grupos de valores:** atención centrada en el paciente, compromiso, innovación, profesionalidad y trabajo en equipo.
- **3 ámbitos asistenciales:** atención hospitalaria; centros de salud mental (adultos e infanto-juvenil); y estructuras intermedias (rehabilitación comunitaria, HD de psiquiatría y centros de adicciones).

Unidades hospitalarias y su estancia media

- **Agudos (intervención breve):** crisis con **riesgo para sí o para terceros**; restaurar el daño y los vínculos. **Máximo 15 días.**
- **Subagudos:** remisión de síntomas y **prevención de recaídas**; permite reevaluar el diagnóstico. **Máximo 3 a 4 meses.**
- **Rehabilitación intensiva:** trastorno mental grave refractario; unidades **estructuralmente abiertas y funcionalmente semiabiertas**. **Unos 6 meses, nunca más de 9.**
- **Rehabilitación funcional:** que el paciente use sus capacidades en el mejor contexto social posible. Sin plazo fijo.
- **Rehabilitación funcional, 3 énfasis:** ayudar a superar el ambiente (no sucumbir a él), orientarse a la salud más que a los síntomas y creer en la recuperación.
- **Intervenciones con evidencia:** entrenamiento en habilidades, apoyo comunitario, rehabilitación cognitiva, cognición social, rehabilitación laboral, servicios de pares, psicoterapias e intervenciones para alcohol, drogas y obesidad.
- **Objetivo último de la GC: efectividad** (mejores resultados en la práctica diaria), **eficacia** (lo que la evidencia demostró) y **eficiencia** (menores costes para el paciente y la sociedad).

Indicadores para evaluar la UGC de salud mental

- **Población:** pacientes nuevos, reinicios (antes de un año), % en programa de trastorno mental grave o común.

- **Actividad:** primeras y sucesivas consultas, crisis, consultas no presenciales, altas.
- **Accesibilidad:** demora en primera consulta; % atendidos en menos de 15 días, menos de 30 y más de 30.
- **Seguridad:** agresiones, fugas, eventos adversos, contenciones, caídas, escitalopram en mayores de 65, valproico en mujeres en edad fértil.
- **Eficacia:** índice sucesivas/primeras, % no presenciales, inasistencias, cancelaciones.
- **Cuidados:** altas derivadas a primaria y abandonos (separados por diagnóstico).
- **Satisfacción:** pacientes y familias satisfechos, recomendarían la UGC, clima laboral, reclamaciones.
- **Resultados en salud:** calidad de vida, adherencia, **conciencia de enfermedad** y actitud ante tóxicos.
- **4 principios éticos: beneficencia**, **no maleficencia**, **autonomía** y **justicia o equidad** («lo mejor posible para todos los enfermos», frente a «lo mejor para mi paciente»).
- **Pregunta ética clave:** ¿la relación beneficio/riesgo es razonable? Todo acto sanitario tiene riesgo físico, psicológico, moral y económico.
- **El estigma tiene 3 piezas: estereotipias** (creencias erróneas, como la incurabilidad), **prejuicios** (actitudes: miedo, desprecio, paternalismo) y **comportamientos discriminatorios** (exclusión). El **autoestigma** es interiorizar esas creencias.
- **Contra el estigma:** psicoeducación, autoestima, conocer los propios derechos y *empowerment*, con la familia desde el inicio. Referentes: Consejo de la UE (junio 2003), **Declaración de Helsinki de la OMS (enero 2005)**, Libro Verde (2005) y Estrategia en Salud Mental del SNS (2007). La primera medida antiestigma corresponde a la **Administración**, con servicios de calidad.
- **Investigación e innovación:** objetivo **traslacional y docente**. Propuesta de innovar con empresas privadas, patentar y repartir beneficios **al 50 %**.
- **Satisfacción:** primero una **encuesta de expectativas**, luego llevarlas al plan de gestión y después medir el impacto en salud. La encuesta de clima laboral evalúa 10 aspectos y separa **reconocimiento** de **retribución**.
- **Incentivos:** económicos, días libres, congresos y estancias. **Regla de los tres tercios** del dinero ahorrado: 1/3 a la nómina de los trabajadores, 1/3 a la UGC y 1/3 al hospital o centro.

Tema 11. Cómo diseñar, implantar y evaluar un plan de calidad

Idea central: el plan de calidad es el **conjunto de actuaciones en calidad** de un servicio o unidad. Funciona solo con la implicación de la dirección, del staff y de los profesionales, y el éxito depende más de cómo se aplica que del modelo elegido.

- **Referentes:** autores como Juran, Deming y Crosby; modelos ISO, **EFQM** y **Joint Commission**; y la acreditación de la comunidad autónoma.
- **Qué contiene:** qué somos y adónde queremos llegar, objetivos, responsabilidades, estrategias, indicadores, calendario y cómo se revisará.

Las 15 recomendaciones (el orden es didáctico, no hay que terminar una para empezar otra):

1. Asegurar que la dirección se implica totalmente (implicarse no es dar permiso: es participar y **asignar presupuesto**).
2. Definir qué es la calidad para nosotros.
3. Identificar clientes internos y externos y lo que nos demandan.
4. Aprovisionarse de **liderazgo, paciencia y tesón**.
5. Lograr la colaboración de los líderes formales e informales (*win-win*).
6. Analizar el entorno y conocer otras experiencias.
7. Posicionarse.
8. Analizar las barreras y tener un plan B.
9. Describir el marco general de actuación (acotar límites).
10. Diseñar el sistema de calidad.
11. Establecer la calidad de diseño.
12. Fomentar la cultura de calidad.
13. Formalizar la documentación.
14. Asegurar la información: cuadros de mando.
15. Revisar objetivos, despliegue y resultados.

- **Oferta frente a demanda:** el círculo rojo son las necesidades y expectativas del cliente; el cuadrado azul, nuestra oferta. Si la oferta se queda corta hay que rediseñar; si se pasa, puede despertar expectativas (bueno) o gastar de más (malo).
- **Tres preguntas al cliente:** qué es calidad para él, qué necesita y no tiene, y qué espera que le demos.

- **Método de 8 pasos:** averiguar qué necesita el cliente → fijar un estándar → definir recursos → definir cómo prestar el servicio → prestarlo → evaluarlo → mejorar lo débil → **volver a empezar** (el paso que más se olvida).
- **Hacerlo dentro o encargarlo fuera:** lo externo impone calendario y método; a cambio, el personal se implica menos y cuesta más.
- **Alianzas con proveedores (calidad concertada):** identificar a los proveedores clave, elegir alianzas y diseñar estrategias para prevenir fallos.
- **Barreras:** resistencia al cambio, miedo a perder el control, sensación de más trabajo y miedo a «salir mal en la foto». Se diagnostican con el **modelo de desajustes (gaps) de Parasuraman, Zeithaml y Berry**. La calidad no es la «carta a los Reyes Magos». Conviene **empezar por lo fácil** y avanzar de forma gradual.
- **Sistema de calidad:** estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos para gestionar la calidad. Entradas: opinión de los públicos, sugerencias y reclamaciones, encuestas, auditorías e indicadores. Salidas: cuadros de mando, informes trimestrales, memoria anual, no conformidades, planes de mejora e incentivos.
- **Calidad de diseño:** las características que definen la calidad de cada servicio. Ejemplos: responder una reclamación en menos de 48 horas; atender la fibrilación auricular en las primeras 48 horas.
- **Cultura de calidad:** que se «hable» de calidad en todas partes, con un lenguaje cercano. El éxito depende del **número de personas que se suman**.
- **Documento:** plan **escrito y aprobado por la dirección**, con objetivos, acciones, indicadores y estándares.
- **Cuadro de mando:** como el tablero del coche, reúne los indicadores más relevantes para decidir.
- **Revisión del plan:** anual, a mitad de su vigencia o tras una estrategia innovadora. Lo más acertado es comparar indicadores con estándares.
- **Lema:** la calidad se logra «**haciendo bien lo correcto**».

Tema 12. Responsabilidad social corporativa (RSC)

Idea central: la RSC son compromisos **voluntarios** con la sociedad, que van **más allá de la ley**, en tres ámbitos: **económico, social y medioambiental**.

- **Definición de la UE (2002, COM 2002 347):** integrar las preocupaciones sociales y medioambientales en la actividad diaria y en la relación con los **grupos de interés**, de forma voluntaria y más allá de las exigencias legales.

- **Triple cuenta de resultados (o triple memoria):** el informe económico, social y medioambiental que muestra si la organización cumple sus compromisos.
- **Elementos clave en sanidad:** la **transparencia** y un **código ético** en la gestión de recursos.
- **Lo que NO es RSC:** la **filantropía estratégica** (donación según el donante; tampoco es patrocinio), la **gestión medioambiental** sola (es un pilar de tres), el **marketing con causa** (asociar la marca a una causa, como el cinturón de seguridad) y la **imagen corporativa** (visión **efímera**).
- **Reputación corporativa:** percepción **estable y verificable** que se genera dentro; una buena imagen mantenida genera reputación, y la RSC es uno de sus mayores componentes.
- **Historia: 1999** Pacto Mundial de la ONU y **GRI** (guía de informes de triple cuenta) → **2001** Consejo Europeo de **Gotemburgo** → después, **Libro Verde** de la Comisión Europea (Objetivos de Lisboa) → **marzo 2003** primer informe de RSC y Políticas Públicas en España → **2004** el modelo **EFQM** incluye la RSC como eje transversal.
- **Dos enfoques actuales:** países donde la RSC es voluntaria y países donde es obligatoria por regulación.
- **En la práctica:** no son acciones puntuales sino un cambio de estrategia. Un buen primer paso es una **memoria de RSC con indicadores**. Ventajas: mejor reputación, atraer y retener talento, mejores resultados económicos, menos vulnerabilidad ante crisis y personal más satisfecho.
- **Sector sanitario:** casi sin tradición (excepciones: Hospital Virgen de las Nieves y Hospital General de Vic). Se definieron **11 áreas**: recursos humanos y formación, informática y protección de datos, calidad, gestión económica, ambiental, pacientes, ética, proveedores, dirección, comunidad, y docencia e investigación.
- **Escala RSC-HospitalES** (Mira et al., 2013): mide cómo perciben los profesionales la orientación de RSC de su hospital.

Tema 13. Evaluación de resultados de una unidad de gestión clínica

Idea central: evaluar responde a la pregunta **«¿qué se ha conseguido y a qué coste?»**. Es la fase **Check** del ciclo PDCA de Deming y sirve para fijar los objetivos del año siguiente.

- **Evaluación:** proceso de determinar y aplicar criterios e indicadores para emitir un juicio sobre la actividad, tanto al planificar como al ejecutar.
- **Criterio:** norma de lo deseable, lo que queremos conseguir (a veces se le llama meta). **Indicador:** medida cuantitativa que guía y valora la calidad.

- **4 dimensiones a evaluar:** científico-técnica, satisfacción de los pacientes, organización y gestión de personas, y gestión económica y presupuestaria.
- **7 atributos de la GC:** práctica basada en guías y protocolos; modelo de calidad (Joint Commission, EFQM); implicación de los profesionales; continuidad asistencial; organización del trabajo; satisfacción de los usuarios; y eficiencia.
- **Reglas claras desde el inicio:** objetivos e indicadores se pactan y explican antes; la evaluación cambia conforme madura la UGC.
- **Objetivos SMART: e**specíficos (*specific*), **m**edibles, **a**lcanzables, **r**ealistas y en un **t**iempo determinado.

Tipos de indicadores

- **Cuantitativo:** un valor numérico (ablaciones cardíacas con éxito > 95 %; colonoscopia en ingresados < 48 h).
- **Dicotómico:** sí o no (existe un protocolo de úlceras por presión).
- **Cualitativo:** solo si no cabe uno cuantitativo, por su subjetividad.
- **Sintético:** resume una dimensión en **una sola cifra** (indicador sintético de farmacia).
- **Llave:** de **obligado cumplimiento**; si falla, toda la dimensión deja de evaluarse.
- **Ponderación:** cada indicador pesa según su relevancia y su dificultad. Los objetivos difíciles **no deben pesar mucho**, para no desmotivar.
- **Ejemplo real (Hospital XXX, 2015):** presupuesto del capítulo I = 31; capítulo II = 27 (presupuesto 18 + farmacia 9); indicadores de procesos y resultados = 42 (asistenciales 12, seguridad y calidad 12, continuidad 10, información al paciente 4 y sistemas de información 4). Total: 100.
- **Principio de economía:** recopilar **solo la información estrictamente necesaria**, con el menor coste.
- **Pasos:** seleccionar indicadores; identificar fuentes (historia clínica, registros, encuestas); definir un plan de monitorización (responsables y periodicidad); y difundir **resultados preliminares** como señales de alarma.
- **Ejemplo de ficha:** bacteriemias por catéter venoso central, objetivo **≤ 3 por 1000 días de catéter**, fuente ENVIN, la recoge Medicina Preventiva.
- **Auditorías de historias clínicas:** hay que calcular el tamaño de muestra, y los resultados se presentan con **intervalos de confianza**.

Evaluación secuencial en 5 pasos

1. Al cerrar el año, la dirección o una comisión local hace la primera evaluación.
2. La UGC analiza los resultados y presenta **alegaciones**.

3. La dirección del centro valora las alegaciones y hace una propuesta de evaluación interna.
4. Los servicios centrales (comisión central de seguimiento) la contrastan con sus datos.
5. Se aprueba en una **reunión a tres bandas**: gerencia del servicio de salud, dirección del centro y responsables de la UGC.

La puntuación puede traducirse en **productividad variable** (complemento salarial). La **evaluación individual** fija objetivos para cada profesional, alineados con la unidad; puede incluir una **evaluación de 180°** (superiores y compañeros), que exige madurez organizativa.

Tema 14. El ciclo de mejora

Idea central: la mejora continua es un **principio transversal** de la cultura sanitaria y se aplica con el ciclo **PDCA**: planificar, hacer, verificar y actuar.

- **Origen de la participación del personal:** la **Teoría Z de W. Ouchi**.
- **Equipos de mejora:** profesionales afectados por un **mismo problema**, voluntarios, durante un **tiempo limitado**.
- **Círculos de calidad:** voluntarios que trabajan **largos períodos**, unas horas por semana, para mejorar sus procesos. Primer círculo: **Japón, 1949**; en España los introdujo **Ford en 1980**.
- **Comisión clínica:** el tipo de equipo propio de sanidad, con reglamento específico.
- **Rasgos de un buen equipo: 8 miembros como máximo**, objetivos compartidos, un líder elegido por ellos, autonomía y formación en herramientas.
- **7 pasos del ciclo de mejora:** identificar y priorizar el problema; analizarlo y recopilar información; buscar soluciones; elegir una; presentarla a la dirección; ejecutarla; y evaluarla.
- **Historia del PDCA:** lo creó **Walter A. Shewhart** (estadístico) en los **años 30** y lo popularizó **Edward Deming** en los **50**; por eso se le llama «círculo de Deming». No tiene final; se detiene cuando las mejoras ya no son coste-efectivas (proceso estabilizado).
- **Plan (planificar):** fijar objetivos y límites del proyecto, definir indicadores y recopilar datos.
- **Do (hacer):** implantar el cambio, de preferencia con un **piloto a pequeña escala**; mejor cambios pequeños y frecuentes.
- **Check (verificar):** comparar los indicadores con los objetivos.

- **Act (actuar):** incorporar la mejora, comunicarla e identificar nuevos problemas; si no funcionó, probar otra acción.
- **Herramientas de la calidad:** diagrama de causa-efecto, listas de verificación, diagramas de flujo, histogramas, **diagrama de Pareto** y gráficos de control (también lluvia de ideas y matriz de decisión).
- **Matriz de priorización:** opciones contra criterios; se puntúa (p. ej., de 1 a 5), se suma y se empieza por la opción con **mayor puntuación**.
- **Mejora gradual o continua:** perfecciona lo que existe. **Mejora radical:** rehace el proceso desde la raíz y abandona lo previo.
- **Kaizen:** *kai* = cambio y *zen* = mejora continua gradual y ordenada; es la «**mejora continua que involucra a todos**». Requiere tiempo, concienciación y disciplina.

Glosario

Los 53 términos y siglas que más aparecen, en orden alfabético y con su tema entre paréntesis. Para repasar, lee el término y trata de definirlo antes de leer la definición.

- **Acuerdo o contrato de gestión:** pacto **anual** de objetivos entre una unidad y su gerencia (1, 13).
- **Área sanitaria:** estructura que gestiona centros, recursos y prestaciones de un territorio (8).
- **Autoestigma:** interiorizar las creencias negativas sobre la propia enfermedad (10).
- **Aval ciudadano:** participación de la comunidad en la calidad de los servicios, en México (4).
- **Benchmarking:** compararse con otros para aprender y mejorar (2, 3, 6).
- **Calidad de diseño:** características que definen la calidad de cada servicio (11).
- **Cartera de servicios:** conjunto de prestaciones: técnicas, tecnologías y procedimientos (1, 9).
- **CENETEC:** Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; coordina las GPC en México (5).
- **Círculo de calidad:** grupo voluntario y estable que mejora sus propios procesos (14).
- **COCASEP:** Comité de Calidad y Seguridad del Paciente; órgano técnico consultivo (4).
- **Continuidad asistencial:** atención sin cortes entre atención primaria y especializada (1, 8).
- **Criterio:** condición que debe cumplir la práctica para ser de calidad (2, 13).

- **Cuadro de mando:** conjunto de indicadores clave para tomar decisiones (11).
- **DAFO:** debilidades y fortalezas (internas); amenazas y oportunidades (externas) (1).
- **DCA:** Dirección de Continuidad Asistencial, Madrid 2015 (1).
- **Eficacia:** resultado que la evidencia demostró posible (10).
- **Efectividad:** resultado logrado en la práctica diaria (10).
- **Eficiencia:** resultado con el menor coste para el paciente y la sociedad (10).
- **Equipo de mejora:** afectados por un mismo problema; voluntarios; tiempo limitado (14).
- **Estándar:** nivel aceptable que debe alcanzar un indicador (2).
- **Estigma:** estereotipias + prejuicios + comportamientos discriminatorios (10).
- **Evaluación de 180°:** evaluación del desempeño por superiores y compañeros (13).
- **Gestión clínica (GC):** práctica clínica + gestión de recursos (1, 3).
- **GPC:** guía de práctica clínica, con recomendaciones basadas en evidencia (5).
- **GRI:** Global Reporting Initiative (1999), guía para informes de RSC (12).
- **Hospital de día (HD):** atención de unas horas, sin internamiento (9).
- **IIS:** Institutos de Investigación Sanitaria, acreditados según el RD 339/2004 (7).
- **INCLASNS:** indicadores clave del SNS español, en 16 dimensiones (6).
- **INDICAS:** indicadores de calidad de México: 111 → 28 → 8 → 3 (6).
- **Indicador:** medida cuantitativa con la que se evalúa un criterio (2, 13).
- **Indicador centinela:** uno de los pocos indicadores clave que cubren lo más relevante (2, 6).
- **Indicador llave:** obligatorio; si no se cumple, toda la dimensión deja de evaluarse (13).
- **Indicador sintético:** resume varios indicadores en una sola cifra (6, 13).
- **Kaizen:** «mejora continua que involucra a todos» (14).
- ***Lex artis*:** práctica basada en la evidencia y centrada en el paciente (4).
- **Macro, meso y microgestión:** Estado, centros y práctica clínica (3).
- **Mapa de procesos:** representación gráfica de procesos estratégicos, clave y de soporte (2).
- **MBE:** medicina basada en la evidencia: uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia (5).
- **MECIC:** evaluación del expediente clínico; mide el apego a las GPC con 11 algoritmos (5).
- **Monitorización:** seguimiento de indicadores; por sí sola no mejora nada (2).
- **PDCA:** Plan, Do, Check, Act; ciclo de Shewhart popularizado por Deming (2, 13, 14).

- **PIR:** plan individualizado de rehabilitación, en salud mental (10).
- **Plan de calidad:** conjunto de actuaciones en calidad de un servicio o unidad (11).
- **Proceso:** actividades encadenadas en secuencia que dan un resultado al paciente (2, 8).
- **Productividad variable:** complemento salarial por cumplir objetivos (13).
- **Propietario del proceso:** responsable que lo gestiona, supervisa y evalúa (2).
- **Reputación corporativa:** percepción estable y verificable de los grupos de interés (12).
- **RSC:** responsabilidad social corporativa; compromiso voluntario económico, social y ambiental (12).
- **Sistema de calidad:** estructura, procedimientos, procesos y recursos para gestionar la calidad (11).
- **SMART:** objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazo (13).
- **Triple cuenta de resultados:** informe económico, social y medioambiental (12).
- **UGC:** unidad de gestión clínica (3, 10, 13).
- **Variabilidad injustificada:** diferencias de práctica sin base científica (3, 5).

Preguntas de práctica

Son 43 preguntas de opción múltiple, en el orden de los temas y con una sola respuesta correcta. Contesta todas antes de ver la clave que viene al final.

1. La gestión clínica se resume como: **a)** la suma de la práctica clínica y la gestión de recursos · **b)** la gestión de recursos sin los clínicos · **c)** el control del gasto farmacéutico · **d)** la acreditación de los servicios
2. En el DAFO, las oportunidades y las amenazas salen del: **a)** análisis interno · **b)** organigrama · **c)** cartera de servicios · **d)** análisis externo
3. Los acuerdos de gestión clínica suelen ser: **a)** mensuales · **b)** trimestrales · **c)** anuales · **d)** quinquenales
4. ¿Qué figura creó Madrid en 2015 para coordinar atención primaria y especializada? **a)** la Dirección de Continuidad Asistencial · **b)** la gerencia departamental · **c)** el Área de Gestión Integrada · **d)** el órgano de gestión
5. Según la ISO 9000:2005, un proceso es: **a)** un conjunto de normas internas · **b)** un organigrama funcional · **c)** un indicador de resultado · **d)** actividades relacionadas que transforman entradas en resultados

6. Los procesos que dan los recursos para que funcionen los clave son los: **a)** estratégicos · **b)** operativos · **c)** de soporte · **d)** centinela
7. Sobre la monitorización, es correcto que: **a)** es el seguimiento de indicadores y por sí sola no mejora el proceso · **b)** basta para mejorar · **c)** sustituye al PDCA · **d)** solo mide costes
8. NO es una característica de un buen indicador: **a)** concreto · **b)** clínicamente válido · **c)** eficiente · **d)** exhaustivo, que mida todo
9. NO es una de las 8 barreras de la gestión clínica: **a)** cultura · **b)** transparencia · **c)** estilos de práctica clínica · **d)** financiación capitativa
10. La gestión de los centros sanitarios corresponde a la: **a)** macrogestión · **b)** mesogestión · **c)** microgestión · **d)** autogestión
11. «Que la gestión sea más clínica y la clínica más gestora» es de: **a)** Ortún · **b)** Deming · **c)** Minúé · **d)** Ouchi
12. El COCASEP es un órgano: **a)** colegiado de carácter técnico consultivo · **b)** ejecutivo y sancionador · **c)** de financiación · **d)** judicial
13. El secretario técnico del COCASEP es: **a)** el director del establecimiento · **b)** la jefatura de enfermería · **c)** el gestor de calidad · **d)** un aval ciudadano
14. Las tres esferas de una organización (Chiavenato y Sapiro) son: **a)** gerencial, técnica y social · **b)** política, económica y legal · **c)** clínica, docente e investigadora · **d)** estratégica, operativa y de soporte
15. Si la evidencia existe pero el profesional no la conoce o no la aplica, la variabilidad se debe a: **a)** incertidumbre · **b)** ignorancia · **c)** la población · **d)** la oferta de servicios
16. La MBE es el uso ___ de la mejor evidencia disponible: **a)** rápido, barato y sencillo · **b)** obligatorio y uniforme · **c)** intuitivo y personal · **d)** consciente, explícito y juicioso
17. El Programa Nacional de GPC de México nació en: **a)** 1999 · **b)** 2003 · **c)** 2007 · **d)** 2012
18. El MECIC mide el apego a las GPC con: **a)** 11 algoritmos · **b)** 28 indicadores · **c)** 16 dimensiones · **d)** 51 indicadores
19. La medicina de las 4P es: **a)** preventiva, predictiva, personalizada y participativa · **b)** pública, privada, primaria y paliativa · **c)** planificar, prevenir, priorizar y proteger · **d)** paciente, profesional, proceso y presupuesto
20. INDICAS mide la calidad con: **a)** 274 líneas de acción · **b)** 7 indicadores y 23 programas · **c)** 111 variables, 28 indicadores y 8 índices · **d)** 51 indicadores en 6 dimensiones
21. El PAF del NHS británico tiene: **a)** 4 dimensiones y 16 categorías · **b)** 18 indicadores · **c)** 16 dimensiones · **d)** 51 indicadores en 6 dimensiones

22. El modelo canadiense se apoya en el informe Lalonde de: **a)** 1974 · **b)** 1986 · **c)** 1994 · **d)** 2006
23. En el modelo de la OMS, los indicadores de equidad se relacionan con: **a)** la mortalidad materna · **b)** los subsidios y el coeficiente de Gini · **c)** las barreras físicas · **d)** el gasto farmacéutico
24. Frente al modelo de la OMS, el de la OCDE: **a)** añade ponderaciones a las metas · **b)** excluye los indicadores de resultados · **c)** amplía la evaluación a toda la salud pública · **d)** excluye cualquier ponderación de las metas
25. La fase T2 de la investigación traslacional es: **a)** la investigación básica · **b)** las posibles aplicaciones de la básica · **c)** la aplicación en la comunidad, en contextos reales · **d)** mantener el beneficio
26. La acreditación de los Institutos de Investigación Sanitaria se regula en: **a)** la Ley 14/1986 · **b)** el RD 1277/2003 · **c)** el RD 339/2004 · **d)** la Ley 16/2003
27. Una barrera para integrar los niveles asistenciales es: **a)** la falta de coordinación administrativa entre niveles · **b)** el exceso de incentivos · **c)** la gerencia única de área · **d)** la telemedicina
28. La definición legal de hospital de día está en: **a)** el RD 1277/2003 · **b)** el RD 339/2004 · **c)** la Ley 11/2017 · **d)** el documento COM 2002 347
29. ¿En qué hospital de día el anestesista da el alta y se abre antes que el resto del hospital? **a)** médico · **b)** quirúrgico · **c)** oncológico · **d)** psiquiátrico
30. Entre 2000 y 2007, las plazas de hospital de día en España llegaron a: **a)** 2,3 por 1000 hab. · **b)** 233 por 100 000 hab. · **c)** 0,23 por 100 000 hab. · **d)** 23,3 por 100 000 hab.
31. La estancia en una unidad de agudos de salud mental no debería pasar de: **a)** 72 horas · **b)** 15 días · **c)** 3 a 4 meses · **d)** 9 meses
32. La estancia en rehabilitación intensiva es de: **a)** unos 15 días · **b)** 3 a 4 meses · **c)** unos 6 meses, nunca más de 9 · **d)** más de un año
33. Con la regla de los tres tercios, el ahorro se reparte entre: **a)** Estado, comunidad y hospital · **b)** pacientes, familias y profesionales · **c)** investigación, docencia y asistencia · **d)** nómina de los trabajadores, UGC y hospital o centro
34. El principio ético que busca «lo mejor posible para todos los enfermos» es: **a)** beneficencia · **b)** no maleficencia · **c)** autonomía · **d)** justicia o equidad
35. En el método de trabajo del plan de calidad, el paso que «a veces se olvida» es: **a)** averiguar qué necesita el cliente · **b)** prestar el servicio · **c)** volver a empezar · **d)** definir el estándar

36. El modelo de desajustes (gaps) para detectar barreras es de: **a)** Juran · **b)** Parasuraman, Zeithaml y Berry · **c)** Shewhart · **d)** Evans y Stoddart
37. NO es RSC según el tema 12: **a)** la triple cuenta de resultados · **b)** los compromisos voluntarios más allá de la ley · **c)** el marketing con causa · **d)** una memoria de RSC con indicadores
38. El modelo EFQM incluyó la RSC como eje transversal en: **a)** 1999 · **b)** 2004 · **c)** 2001 · **d)** 2015
39. Un indicador que, si no se cumple, anula la evaluación de toda una dimensión es: **a)** sintético · **b)** centinela · **c)** llave · **d)** dicotómico
40. El último paso de la evaluación secuencial de una UGC es: **a)** la autoevaluación individual · **b)** una auditoría externa privada · **c)** la encuesta de satisfacción · **d)** una reunión a tres bandas: gerencia del servicio de salud, dirección del centro y UGC
41. Los círculos de calidad llegaron a España de la mano de: **a)** el INSALUD, en 1949 · **b)** Ford, en 1980 · **c)** Toyota, en 1950 · **d)** el Ministerio de Sanidad, en 2006
42. Un equipo de mejora no debe tener más de: **a)** 4 miembros · **b)** 8 miembros · **c)** 12 miembros · **d)** 20 miembros
43. En el ciclo PDCA, comparar los indicadores con los objetivos es la fase: **a)** Plan · **b)** Do · **c)** Check · **d)** Act

Clave de respuestas

1. **a**: GC = práctica clínica + gestión de recursos (T1).
2. **d**: oportunidades y amenazas son externas (T1).
3. **c**: los contratos de gestión son anuales (T1).
4. **a**: la DCA está en el hospital y depende del gerente (T1).
5. **d**: transformar entradas en resultados es la definición ISO (T2).
6. **c**: los de soporte o apoyo aportan los recursos (T2).
7. **a**: «solo con monitorizar, el proceso no mejora» (T2).
8. **d**: debe ser relevante, solo los indicadores necesarios (T2).
9. **d**: la financiación capitativa es un pilar valenciano, no una barrera (T3).
10. **b**: macro = Estado, meso = centros, micro = práctica clínica (T3).
11. **c**: la frase es de S. Minúé (T3).
12. **a**: colegiado y técnico consultivo (T4).
13. **c**: el presidente es el director; el secretario, el gestor de calidad (T4).
14. **a**: sistemas gerencial, técnico y social (T4).

15. **b**: incertidumbre = no hay evidencia; ignorancia = sí la hay (T5).
16. **d**: definición clásica de MBE (T5).
17. **c**: 2007, a cargo del CENETEC (T5).
18. **a**: 11 algoritmos de atención clínica (T5).
19. **a**: atiende enfermos, no enfermedades (T5).
20. **c**: 111 → 28 → 8 → 3 rubros (T6).
21. **d**: 4 dimensiones y 16 categorías es Canadá (T6).
22. **a**: Lalonde 1974; Evans y Stoddart 1994 (T6).
23. **b**: acceso = barreras físicas y económicas; equidad = subsidios y Gini (T6).
24. **d**: la OCDE no pondera y se limita a la asistencia médica (T6).
25. **c**: T0 básica, T1 aplicaciones, T2 comunidad, T3 máximo beneficio, T4 mantener (T7).
26. **c**: RD 339/2004 (T7).
27. **a**: también pobres incentivos y burocracia rígida (T8).
28. **a**: define HD, CMA, cirugía menor y diálisis (T9).
29. **b**: el HD quirúrgico prepara al primer paciente del quirófano (T9).
30. **d**: las plazas se duplicaron mientras bajaban las camas (T9).
31. **b**: agudos 15 días; subagudos 3–4 meses (T10).
32. **c**: unos 6 meses, máximo 9 (T10).
33. **d**: 1/3 nómina, 1/3 UGC, 1/3 hospital o centro (T10).
34. **d**: justicia o equidad, frente a «lo mejor para mi paciente» (T10).
35. **c**: «volvemos a empezar», paso 8 (T11).
36. **b**: modelo de los gaps de la calidad de servicio (T11).
37. **c**: marketing con causa, filantropía e imagen no son RSC (T12).
38. **b**: 2004, revisión del EFQM (T12).
39. **c**: indicador llave = obligado cumplimiento (T13).
40. **d**: gerencia, dirección del centro y UGC (T13).
41. **b**: primer círculo en Japón (1949); Ford en España (1980) (T14).
42. **b**: importa la competencia, pero máximo 8 (T14).
43. **c**: Check = verificar (T14).

Si fallas 3 o más preguntas de un mismo tema, vuelve a leer su resumen completo.

Repaso de último minuto

Si solo tienes 15 minutos antes del examen, lee esta sección: reúne las cifras, los trucos y las confusiones que más se preguntan.

Cifras, leyes y fechas

- **T1:** Soria = nov. 2011, 1600 trabajadores, 120 M€, sello 500+ (2015) · Valencia = 24 departamentos, 4 pilares · Madrid = DCA (2015).
- **T2:** ISO 9000:2005 define el proceso.
- **T4:** 2001 informe europeo de buen gobierno · Ley 11/2017 (Madrid) · COCASEP en el DOF del 27/12/2012.
- **T5:** 2007 Programa Nacional de GPC (CENETEC) · MECIC = 11 algoritmos, cada cuatrimestre.
- **T6:** INDICAS 111 → 28 → 8 → 3 · PROSESA 274 · 39 · 6 · Caminando a la Excelencia 7 indicadores y 23 programas · PAF 51 indicadores y 6 dimensiones · NHPC 3 metas y 18 indicadores · Canadá 1974, 1994, 4 dimensiones y 16 categorías · Plan de Calidad SNS 2006 (estrategia 12) · INCLASNS 16 dimensiones · REBECA 8 grupos · Cataluña 10 indicadores en 4 áreas.
- **T7:** RD 339/2004 · 5 fases (T0–T4).
- **T9:** Ley 14/1986 (General de Sanidad) · Ley 16/2003, art. 13 (Cohesión y Calidad) · RD 1277/2003 (definición de HD) · 23,3 plazas por 100 000 hab.
- **T10:** agudos 15 días · subagudos 3–4 meses · rehabilitación intensiva ~6 meses (máx. 9) · tres tercios · 50 % con empresas.
- **T11:** 15 recomendaciones · método de 8 pasos.
- **T12:** 1999 Pacto Mundial y GRI · 2001 Gotemburgo · 2002 definición UE · marzo 2003 primer informe en España · 2004 EFQM · 11 áreas en hospitales.
- **T13:** ponderación 31 · 27 · 42 · bacteriemias por catéter ⩽ 3 por 1000 días.
- **T14:** Shewhart años 30, Deming años 50 · primer círculo Japón 1949, Ford en España 1980 · máx. 8 por equipo.

Trucos para memorizar listas

- **P-O-D-E**, las fases de la GC: Planificar, Organizar, Dirigir, Evaluar.
- **«CLOE FEST»**, las 8 barreras de la GC: Cultura, Liderazgo, Organización, Estrategia, Formación, Estilos de práctica, Sistemas de información, Transparencia.
- **E-C-S**, los tipos de procesos: Estratégicos, Clave, Soporte.

- **T0 → T4**, la investigación traslacional: básica, aplicar, comunidad, máximo beneficio, mantener.
- **SMART**: Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas, con Tiempo.
- **E-P-D**, el estigma: Estereotipias (lo que se cree), Prejuicios (lo que se siente), Discriminación (lo que se hace).
- **B-N-A-J**, la ética: Beneficencia, No maleficencia, Autonomía, Justicia.
- **4P**: preventiva, predictiva, personalizada, participativa.

Confusiones típicas

- **Equipo de mejora** (un problema, tiempo limitado) ≠ **círculo de calidad** (largos períodos, horas semanales).
- **Indicador sintético** (resume en una cifra) ≠ **llave** (obligatorio) ≠ **centinela** (pocos y clave).
- **Incertidumbre** (no hay evidencia) ≠ **ignorancia** (la hay y no se usa).
- **Eficacia** (lo que demostró la evidencia) ≠ **efectividad** (lo logrado en la práctica) ≠ **eficiencia** (al menor coste).
- **Criterio** (lo deseable) ≠ **indicador** (cómo se mide) ≠ **estándar** (el nivel aceptable).
- **INCLASNS**, 16 dimensiones (España) ≠ **Canadá**, 4 dimensiones y 16 categorías.
- **Imagen corporativa** (efímera) ≠ **reputación** (estable y verificable).
- **Mejora gradual** (perfecciona) ≠ **mejora radical** (rehace desde la raíz).

Plan de estudio en 4 sesiones

1. **Temas 1, 2, 3 y 8** (gestión clínica y procesos) y sus preguntas: unas 2 h.
2. **Temas 4, 5, 6 y 7** (gobierno, variabilidad, desempeño e investigación) y sus preguntas: unas 2 h 30 min.
3. **Temas 9 a 14** (hospital de día, salud mental, calidad, RSC, evaluación y mejora) y sus preguntas: unas 2 h 30 min.
4. **Glosario, las 43 preguntas seguidas** y repaso de los temas donde fallaste: 1 h 30 min.

La víspera, lee solo esta sección y la clave de respuestas. Toda la guía sale únicamente del PDF del curso (UNIR, Gestión en Salud, temas 1 a 14).